CLÍNICA SALUS INFIRMORUM

MANUAL D' ORGANITZACIÓ

SALU-GG-EST-E-04-02

Pla Estratègic 2023-2026

Tipus de document:	Estratègic	**Centre:**	Clínica Salus Infirmorum
Responsable(s):	Gerència	**Procés:**	Gestió del Govern i Lideratge/ Panificació Estratègica

Circuit d'aprovació del document

	Nom	Unitat organitzativa	Signatura
Elaborat per:	Àngel Gómez Roig / Veure apartat 2	Gerent	
Revisió:	Consell de direcció		
Aprovació:	Junta Delegada GG		

Creació, actualització i revisió

Data	Versió	Naturalesa del document	Nº. Pàgines
05-2023	01	Creació	36
09-2024	02	Actualització	37

Índex

Índex ... 2
1 Presentació i justificació ... 4
2 Participació en l'elaboració del Pla Estratègic 2023 ... 5
2.1 Grups de treball interns ... 5
2.2 Grups de treball externs ... 5
3 Missió, visió i valors ... 6
3.1 Missió ... 6
3.2 Visió ... 6
3.3 Valors ... 6
3.3.1 Servei ... 6
3.3.2 Acollida ... 6
3.3.3 Respecte ... 6
3.3.4 Humilitat ... 6
4 La Clínica Salus Infirmorum a la comarca del Pla de l'Estany ... 7
5 Anàlisi DAFO ... 9
5.1 Febleses ... 9
5.2 Fortaleses ... 10
5.3 Amenaces ... 11
5.4 Oportunitats ... 11
6 Utilització dels serveis sanitaris per la població ... 12
7 Cartera de serveis i dotació estructural ... 13
7.1 Atenció especialitzada ... 13
7.2 Atenció intermèdia ... 14
7.3 Dotació estructural ... 15
8 Organigrama i equip directiu ... 16
9 Atenció especialitzada d'aguts ... 16
9.1 Contractació pública ... 16
9.2 Activitat d'urgències ... 20
9.3 Relacions amb tercers, àmbit públic ... 21
9.4 Atenció Primària de Banyoles ... 21
9.5 Atenció privada ... 21
10 Atenció intermèdia ... 23
10.1 Activitat Intermèdia pública de la CSI ... 23
10.2 Planificació de l'atenció intermèdia ... 23
10.3 Dispositius sanitaris i socials del Pla de l'Estany ... 25
10.4 Activitat Intermèdia privada ... 26
11 Satisfacció i fidelitat ... 26
12 Recursos Humans ... 26
13 Conclusions i línies de treball futures ... 27
14 Eixos estratègics ... 28

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.1 Organització eficient i sostenible 28
14.1.1 Sostenibilitat amb equilibri pressupostari 28
14.1.2 Millorar la gestió administrativa – econòmica....30
14.1.3 Noves tecnologies per millorar l'eficiència 31
14.1.4 Eficiència energètica i ecològica dels edificis/espais 31
14.2 Model Assistencial excel·lent i accessible a la població 32
14.2.1 Millorar les estructures, equipaments i instal·lacions 32
14.2.2 Desenvolupament de la Clínica i augment de resolució 33
14.2.3 Reorientar l'Atenció intermèdia seguint criteris del Pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya 2023....34
14.2.4 Avançar en qualitat i seguretat del pacient 34
14.3 Desenvolupament professional i gestió de les persones 34
14.3.1 Reconeixement i promoció professional....34
14.3.2 Potenciar les habilitats i l'expertesa professional 36
14.3.3 Potenciar el lideratge dels comandaments 36
14.3.4 Atracció i fidelització de professionals....36
14.3.5 Millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral 37
14.4 Comunicació, participació i accessibilitat....37
14.4.1 Millora de la Comunicació interna i externa 37
14.4.2 Atenció a l'usuari....38
14.4.3 Avançar en la Responsabilitat Social....38
15 Responsabilitat del Pla Estratègic....38
16 Vigència, revisió i actualització....38
17 Ubicació de les còpies i formats....38

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

1 Presentació i justificació

Al sector de la salut s'hi estan produint reflexions de relleu a tots els seus àmbits, amb l'objectiu, principalment, de preveure amb la major precisió possible quins són els escenaris de futur més probables, quines accions són les idònies per respondre als reptes sanitaris immediats i de mig termini, i quin paper han de jugar-hi els diversos actors de l'atenció sanitària i social. Les exigències de servei són elevades i progressives (amb salts quantitatius de fort impacte, com el que suposarà l'envelliment de la denominada "generació del baby boom"). La tecnologia plantejarà noves solucions als problemes de salut, però tensionarà encara més les finances públiques.

El model d'atenció haurà de reconèixer de forma inequívoca a les persones al seu centre, recollint les seves necessitats i preferències des del mateix moment de la planificació dels serveis, i amb respostes assistencials integrades. Unes persones que, com a pacients, estan molt més informades que abans, són més crítiques i exigents, i demanen participar més de les decisions que els afecten. Alhora, en tant que col·lectiu de persones més envellides, la societat catalana tindrà més ciutadans i ciutadanes amb necessitats d'atenció complexes: segons dades de l'IDESCAT i de les Memòries d'activitat anual del CatSalut, si a l'any 2021 hi havien a Catalunya unes 451.000 persones de 80 anys i més, en un escenari mitjà de conservadorisme s'espera que aquest grup poblacional creixi als anys 2030, 2040 i 2050, respectivament, a unes 558.000, 712.000 i 911.000 persones. És a dir, s'esperen augments relatius del nombre de persones que tindran 80 anys i més de l'ordre del 24%, 58% i 102% per d'aquí a 7, 17 i 27 anys, respectivament.

L'ordre de magnitud de les xifres anteriors ja il·lustra la naturalesa del repte que enfronta el nostre sistema d'atenció social i sanitària a les persones. Gaudir d'una bona planificació territorial dels recursos assistencials serà clau per garantir una resposta àgil a les necessitats, que garanteixi l'accés dels ciutadans/es al sistema independentment del seu lloc de residència, i amb veritable contínuum assistencial.

La Clínica Salus Infirmorum (CSI), pertanyent a l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), com a centre sanitari d'aguts i d'atenció intermèdia proveïdor del Servei Català de la Salut, ha dut a terme als darrers anys una important tasca de millora i renovació dels seus equipaments, infraestructura i serveis, i ha realitzat un esforç notable quant a la seva aportació al sistema, que s'ha reflectit en un augment de la seva activitat i la complexitat de la mateixa. La visió i vocació del Centre, amb el suport de l'IRSJG, és configurar-se en un agent actiu de proximitat i de referència al Pla de l'Estany en l'atenció sanitària i sociosanitària en totes les seves vessants, reforçant i revisant les línies de serveis actuals i explorant la incorporació d'altres noves, seguint les indicacions de la Regió Sanitària del CatSalut i les directrius que marqui a cada moment el Pla de Salut de Catalunya, i en col·laboració amb l'Atenció Primària i els Centres hospitalaris d'aguts de Girona, així com amb els Centres residencials de la zona.

El model d'atenció ha de continuar sent **integral, transversal i de proximitat**, seguint les directrius del Pla de Salut, disposant de mecanismes d'avaluació per a la millora contínua, situant a les persones al centre de l'atenció, reforçant la seva participació com a agents actius de la seva pròpia salut, així com la dels professionals com a font de coneixement multidisciplinar, per facilitar l'assoliment d'uns bons resultats de salut i d'atenció.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

El Pla estratègic de la CSI es l'eina necessària per orientar i dirigir l'organització en el futur als propers anys, i s'ha d'anar actualitzant periòdicament, adaptant-hi els seus objectius en base als canvis de l'entorn, del sector sanitari i sociosanitari, i dels requeriments de les autoritats sanitàries i socials. Aquest pla s'ha redactat amb la participació dels directius i professionals de l'IRSJG i la CSI, i les aportacions dels responsables sanitaris, autoritats locals, associacions i fundacions de l'entorn, i d'altres persones de rellevància del sector sanitari, amb l'objectiu de garantir la millor resposta possible de millora de la salut i el benestar de la població de referència, atenent els reptes immediats, però amb visió de futur, alhora que assegurant la sostenibilitat de la nostra organització.

2 Participació en l'elaboració del Pla Estratègic 2023

Març-Agost	Maig-Agost	Setembre- Octubre
Treballs interns	Participació externa i esborrany del Pla estratègic 2023-2026	Aprovació del Consell de direcció del Centre (CSI), i de la Junta Delegada del Govern General de l'IRSJG.

2.1 *Grups de treball interns*

- Consell de Direcció, i Germana Superiora de la Comunitat de la CSI (IRSJG).
- Comandaments intermedis de la CSI.
- Director general i membres dels Serveis Corporatius de l'IRSJG.
- Professionals de la CSI de totes les categories.

2.2 *Grups de treball externs*

- Persones referents del sector de salut i social.
- Alcalde de Banyoles, i Regidoria de Benestar i Salut.
- Director de la Regió Sanitària de Girona (CatSalut).
- Departament de Salut de Girona.
- Principals responsables de les Asseguradores sanitàries de Girona.
- Stakeholders de la zona i Girona.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

3 Missió, visió i valors

3.1 *Missió*

Atendre les persones en les seves necessitats assistencials i espirituals, mitjançant una atenció de qualitat, tracte amable i respectuós en un marc de sostenibilitat.

3.2 *Visió*

Ser reconegut per la població de la comarca i l'entorn proper com el seu centre de referència sanitari i sociosanitari centrat en les persones, d'alta qualitat d'atenció, acollidor, respectuós, innovador i obert, en el que els seus professionals es desenvolupen integralment donant resposta als compromisos i necessitats.

3.3 *Valors*

3.3.1 Servei

Tenir cura de les persones, proporcionant una atenció integral, càlida i humana.

Per viure millor el valor del servei, es proposa posar en pràctica les virtuts següents: justícia, lleialtat i empatia.

3.3.2 Acollida

Rebre i acompanyar amb calidesa i proximitat.

Per viure millor el valor de l'acollida, es proposa posar en pràctica les virtuts següents: empatia, compromís, constància i entusiasme.

3.3.3 Respecte

Valorar la persona, reconeixent la seva dignitat i tractant-la amb consideració.

Per viure millor el valor del respecte, es proposa posar en pràctica les virtuts següents: coherència i prudència.

3.3.4 Humilitat

Ser persones assequibles, honestes i bondadoses.

Per viure millor el valor de la humilitat, es proposa posar en pràctica les virtuts següents: senzillesa, honestedat i generositat.

Servir i vetllar en **missió compartida**, fent aflorar la nostra pròpia cultura institucional, sent humanitzada, forta i transformadora i amb corresponsabilitat, participació i compromís.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

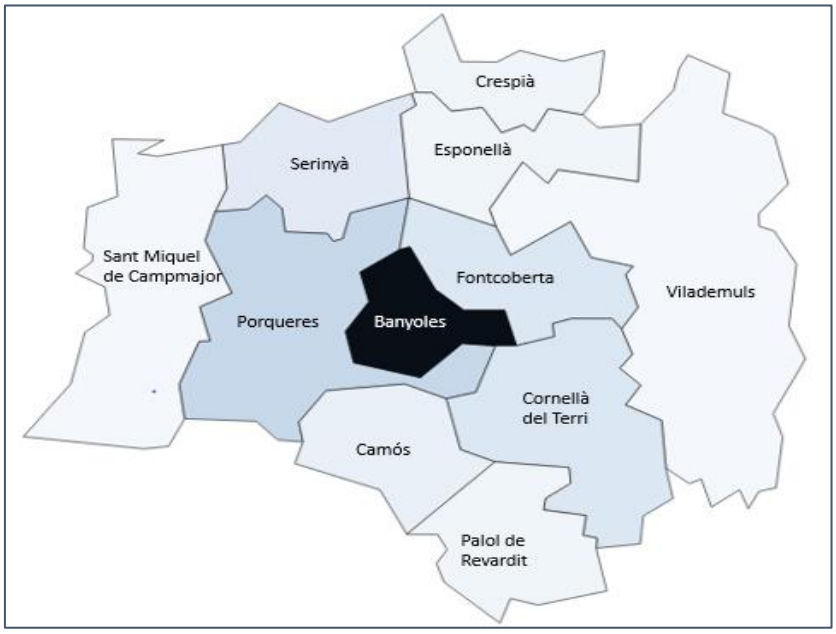
4 La Clínica Salus Infirmorum a la comarca del Pla de l'Estany

La Clínica Salus Infirmorum (CSI) forma part del grup Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), una institució religiosa sense ànim de lucre nascuda a Girona l'any 1870 de la mà de Maria Gay Tibau. L'Institut presta assistència sanitària i social, serveis i educatius arreu del món, estant present en països d'Europa (Espanya i Itàlia), centre i sud Amèrica (Mèxic, Colòmbia, Perú, Equador i Argentina) i Àfrica (Ruanda, Congo, Camerun, Guinea Equatorial i Kenia), amb centres propis o en col·laboració.

La CSI és un centre d'atenció sanitària i sociosanitària situat a la ciutat de Banyoles, que forma part de l'Àrea de Gestió Assistencial (AGA) del Gironès Nord i Pla de l'Estany. L'IRSJG va començar la seva activitat a Banyoles a l'any 1880, i l'edifici actual de la Clínica es va construir a l'any 1964. Des de l'any 2008 forma part del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT).

La Clínica dona feina a 180 treballadors amb contracte laboral, i col·labora amb més de 60 professionals externs en règim de contracte mercantil.

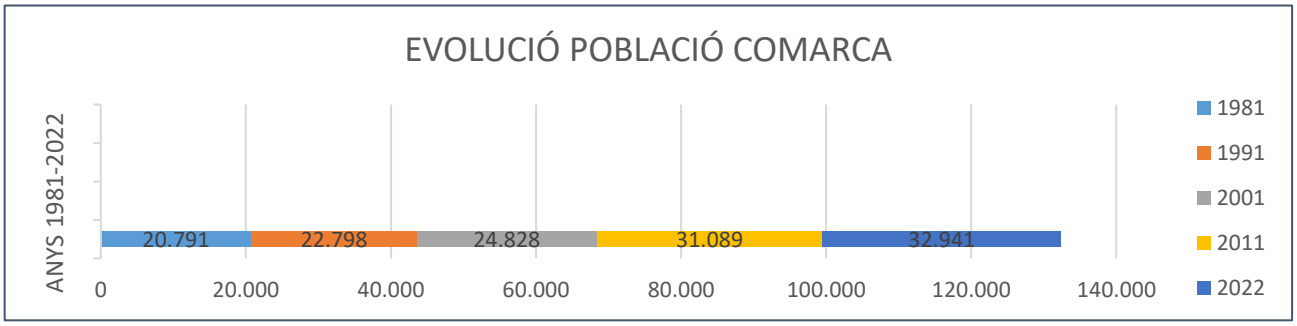
L'àrea d'influència principal és la comarca del Pla de l'Estany, que inclou els municipis de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, el que suposa una població total de 32.941 habitants.



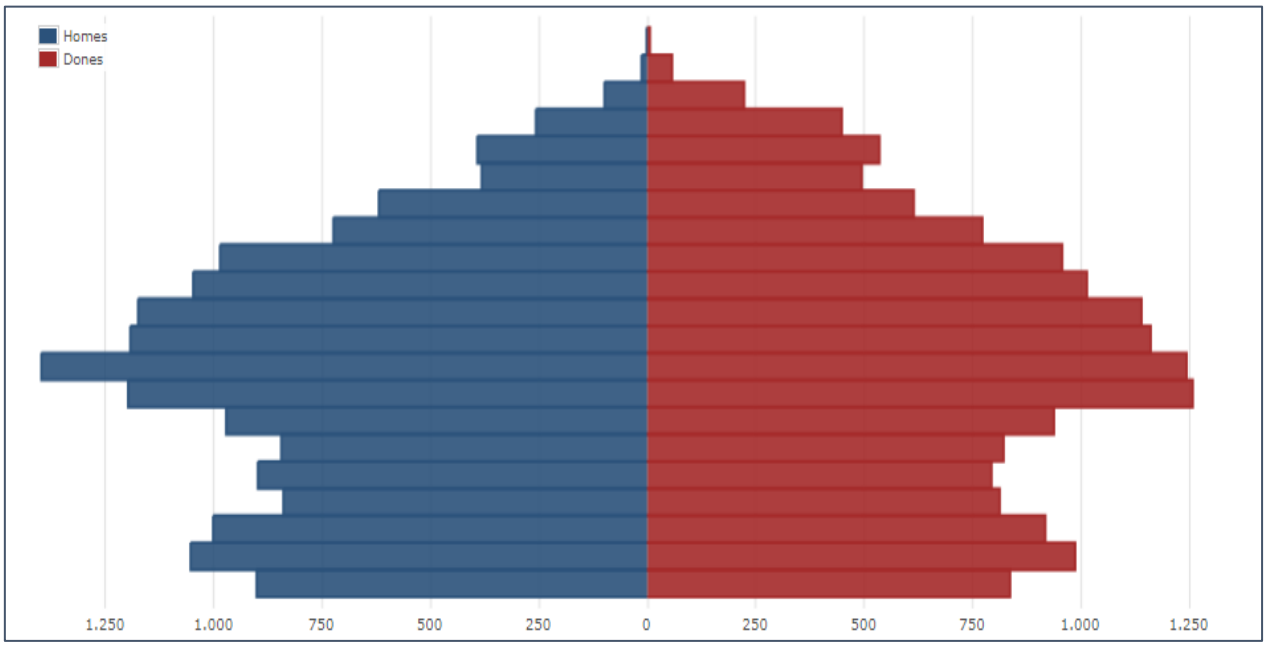
Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

	Banyoles	Pla de l'Estany	Catalunya
Població	20.492	33.213	8.005.784
Densitat de població (hab/km2)	1854,5	126,3	246,1
Població +65 anys (%)	18,18%	18,47%	19,35%
Renda familiar disponible bruta	17.000€	17.000€	17.600€
Titulats universitaris (>16 anys)	31,5%	19,73%	31,8%

Font: *IDESCAT 2022*



La piràmide de població de la comarca Pla de l'Estany, igual que a Catalunya, té forma de piràmide regressiva: baixa natalitat i mortalitat, mentre que el gruix de la població es troba en edats intermèdies.



Font: *IDESCAT. Piràmide poblacional del Pla de l'Estany*

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

La CSI compta amb altres dispositius d'àmbit hospitalari públics propers i accessibles que exerceixen atracció sobre l'àrea de referència de la comarca. L'Hospital Dr. Trueta és qui atreu més pacients de l'ABS que necessiten atenció especialitzada.

Destí	Nivell hospital de destí	Temps de trajecte amb cotxe
H. U. Dr. Josep Trueta (referència)	5	22 minuts
H. de Santa Caterina	3	26 minuts
Clínica Girona	1	30 minuts
H. de Figueres	3	41 minuts
H. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	2	34 minuts

Font: *Mapa de recursos sanitaris del CatSalut*

5 Anàlisi DAFO

Estudia les característiques internes de la CSI, febleses i fortaleses, i les externes - entorn, amenaces i oportunitats.

5.1 *Febleses*

- Infrautilització dels serveis de la CSI pels pacients de la comarca, públics i privats.
- Baix coneixement dels serveis existents.
- La majoria d'especialitats mèdiques estan en procés de consolidació, a excepció de la Traumatologia.
- Escasses proves diagnòstiques, i amb insuficient ús per l'atenció pública.
- Servei d'Urgències amb grau de resolució baix-mig, amb alta derivació a Girona.
- Servei d'Urgències amb horari reduït per a l'atenció pública.
- Cultura dels professionals decantada cap a la visió de servei públic, a voltes amb menys proactivitat de la desitjable.
- Activitat privada testimonial.
- Insuficient transmissió de l'estratègia del centre, i de feed-back amb els professionals mèdics.
- Manca d'espais per desenvolupar l'activitat assistencial i de serveis generals, pels professionals i pacients/familiars.
- Reforma d'espais i estructures inacabada i insuficient.
- Manca d'un pla director d'actualització i reforma de les instal·lacions i d'estructures que genera

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

insatisfacció per les condicions estructurals.

- Sistemes d'informació i TIC poc desenvolupats , amb baixa explotació de dades.
- Dèficits en la coordinació entre àrees, en l'aplicació i visió global dels processos interns, de treball en equip i mètode. Mapa de processos per actualitzar amb procediments i responsabilitats.
- Organització poc innovadora i amb insuficient adaptació als canvis.
- Manca d'empoderament dels professionals i de major autoavaluació.
- Poc interès en formació innovadora, i recerca.
- Insuficients recursos d'escolta als pacients/familiars, en la Unitat d'Atenció a l'Usuari.
- Escassa presència en activitats comunitàries i de participació ciutadana.

5.2 *Fortaleses*

- Grau de notorietat i de prestigi elevats a la comarca, amb alta fidelitat
- Únic centre sanitari amb internament d'aguts i d'intermèdia de la comarca.
- Equilibri pressupostari.
- Forma part de l'IRSJG, organització sense ànim de lucre social i sanitària sòlida, amb més de 150 anys de trajectòria, i presència a 13 països. Bona implantació de l'IRSJG a Girona (amb 4 centres) amb bona reputació.
- Model de clínica familiar.
- Bones relacions amb l'Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal del Pla de l'Estany i altres entitats de la zona, amb diverses vies obertes de col·laboració.
- Contractes amb el CatSalut, ICS i IDI.
- Aliances estratègiques, i de col·laboració entre serveis sanitaris de l'entorn, amb Acord-Conveni Marc amb l'ICS, i IDI, com a centre complementari per la Regió sanitària de Girona.
- Clínica general ben dotada amb tots els serveis bàsics.
- Clínica reconeguda per gaudir d'uns processos de quiròfan àgils i eficients.
- Referència mèdica en l'especialitat de Traumatologia.
- Urgències públiques integrades en un PAC dins de la CSI.
- Proximitat i accessibilitat a la ciutadania, amb tracte proper i amb bona qualitat assistencial.
- Actuacions de reforma i millora de l'equipament i estructures.
- Bon clima laboral, amb personal compromès, tant directius com professionals de base. Personal fidelitzat, amb sentiment de pertinença a la CSI i a l'IRSJG.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

- Expectatives de millora i d'enfortiment del projecte amb il·lusió col·lectiva per escenaris futurs.
- Bona evolució de la comunicació interna i externa (enquestes de satisfacció, reconeixement...).

5.3 *Amenaces*

- Model sanitari en transició, amb marc legal complex i incert.
- Necessitats d'increment de despesa al sistema, amb un grau d'endeutament públic ja elevat.
- Elevat flux de derivació de pacients des dels ABS a l'Hospital Dr. Trueta.
- Manteniment de l'estatus de la CSI per part del CatSalut, amb activitat contractada i sistema de pagament desfasat.
- Escàs poder d'atracció sumat a la manca de professionals al sector.
- Mútues amb presència insuficient a la clínica.
- Competència d'altres proveïdors sanitaris, i sociosanitaris, amb notable fidelització als centres de Girona.
- Ritme d'adaptació i de competència professional lent, que dificulta atendre les oportunitats de mercat.
- Baix coneixement de l'entorn sobre les prestacions de la Clínica, encara amb imatge de centre poc resolutiu.
- Lenta adequació de les estructures i instal·lacions, allunyades de les necessitats, expectatives i la competència, amb alta necessitat d'inversions.
- Canvi accelerat de la societat i les seves expectatives: major exigència, envelliment, cronicitat...
- Lenta implantació dels sistemes d'informació
- Canvi en els valors laborals i humans de les noves generacions professionals.

5.4 *Oportunitats*

- Ciutat de Banyoles i comarca utilitzen la sanitat privada (més 50 % de la població).
- Creixement poblacional de la zona.
- Ampliació de la cartera d'especialitats, d'equipament de proves diagnòstiques i d'activitat.
- Trajectòria als darrers anys de millora de la capacitat de resolució i activitat a tots els serveis.
- Atracció de nous clients privats, i alhora de diversificació de finançament.
- Aconseguir la localització del Centre Català de l'Esport a la CSI
- Aprofundiment de la col·laboració amb ABS, hospitals de Girona, i centres residencials.
- Flux de pacients per alleugerir les llistes d'espera d'hospitals de tots els centres hospitalaris

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

de la Regió.

- Reforçar l'estatus amb el CatSalut com a clínica de proximitat de la comarca, amb més prestacions, qualificació i finançament, i per tota la Regió sanitària.
- Potenciació del contingut de l'Acord Marc amb l'ICS i l'IDI.
- Intensificar els acords i valoracions de les autoritats sanitàries i locals, de les Mútues, i de la població.
- Nou Pla estratègic de CSI.
- Implantació de les millores i canvis engegats en els sistemes d'informació i TICs de l'IRSJG. Implantació d'un nou HIS (Ekon).
- Pla director de remodelació i millora d'espais assistencials, instal·lacions i equipaments, en marxa.
- Reforç de la comunicació i la imatge de la CSI, accessible, confiable i bona cobertura assistencial
- Avenç en el lideratge en el model d'organització de l'atenció integral.
- Reorganització de les àrees i del seu funcionament, adaptat a les expectatives dels usuaris.
- Formació orientada a la millora de capacitats i especialització, per guanyar capacitat de resolució.
- Política d'incentivació i reconeixement als professionals líders.
- Augment de les col·laboracions en docència professional i universitària, i en recerca.
- Línies de gestió mediambiental de l'IRSJG.

6 Utilització dels serveis sanitaris per la població

Pel que fa a la hospitalització d'aguts públics, la utilització que en fan els usuaris del Pla de l'Estany és menor que els usuaris de la resta de Catalunya, fruit de l'alta derivació des de Atenció Primària a Girona.

L'atenció sociosanitària té un rati d'utilització superior en llarga estada dels usuaris si consideren només l'ABS de Banyoles, fet que no es compleix al rebre ingressos d'altres zones de l'AGA del Gironès Nord. Respecte als malalts de mitja estada polivalents i cures pal·liatives és possible un creixement de l'ABS de Banyoles, i més si considerem l'AGA.

En relació a l'ABS de Banyoles, actualment només és fan les proves de radiologia convencional, les ressonàncies magnètiques (conveni amb l'IDI) i la rehabilitació i logopèdia, però és podria avançar en d'altres de que disposa la CSI.

La competència de les clíniques privades es situa a la ciutat de Girona, amb tres centres per ordre d'atracció i capacitat: Clínica Girona, Clínica Bofill i Clínica Onyar.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

La dotació d'especialitats i de mitjans de les clíniques Girona i Bofill es superior a la CSI, a més la primera clínica té una imatge comunicativa potent, amb un important flux de clients que busquen ser atesos fora de la comarca.

En l'esfera privada cal augmentar el nombre d'especialitats i la dotació de mitjans diagnòstics, i fer-los conèixer, per ser més atractius i donar els serveis mancats a la comarca, el que redundarà en la reversió del flux dels clients que son atesos a Girona.

A la comarca i Banyoles els dispositius assistencials privats son consultoris més petits i infradotats que la CSI.

7 Cartera de serveis i dotació estructural

7.1 *Atenció especialitzada*

Especialitats mèdiques	Especialitats quirúrgiques	Serveis terapèutics de suport
Anestesiologia i reanimació	Cirurgia general i digestiva	Farmàcia hospitalària
Aparell digestiu	Cirurgia ortopèdica i traumatologia	Fisioteràpia
Cardiologia	Cirurgia vascular i angiologia	Logopèdia
Dermatologia	Dermatologia	Odontologia
Medicina interna	Oftalmologia	Psicologia
Reumatologia	Otorinolaringologia	Rehabilitació
Pediatria	Urologia	Clínica del dolor
Psicologia	Ginecologia	Podologia
Al·lèrgia	Cirurgia Plàstica i estètica	Medicina Neural
Foniatria		Urgències generals
Medicina de l'Esport		Acupuntura

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Serveis de diagnòstic	Recursos d'hospitalització d'aguts	Serveis als clients
Anatomia patològica	Consultes externes	Atenció a l'usuari
Diagnòstic per la imatge	Hospitalització d'adults	Treball social
Endoscòpia digestiva	Bloc quirúrgic	Pastoral de la salut
	Servei d'urgències 24 h	
	Unitat de cirurgia sense ingrés	

7.2 *Atenció intermèdia*

Atenció sociosanitària	Hospital de dia
Llarga estada	Rehabilitació funcional, i millora de l'estat físic
Mitjana estada polivalent	Avaluació geriàtrica integral
	Manteniment de les capacitats cognitives
	Suport i contenció als cuidadors
	Descàrrega del cuidador principal

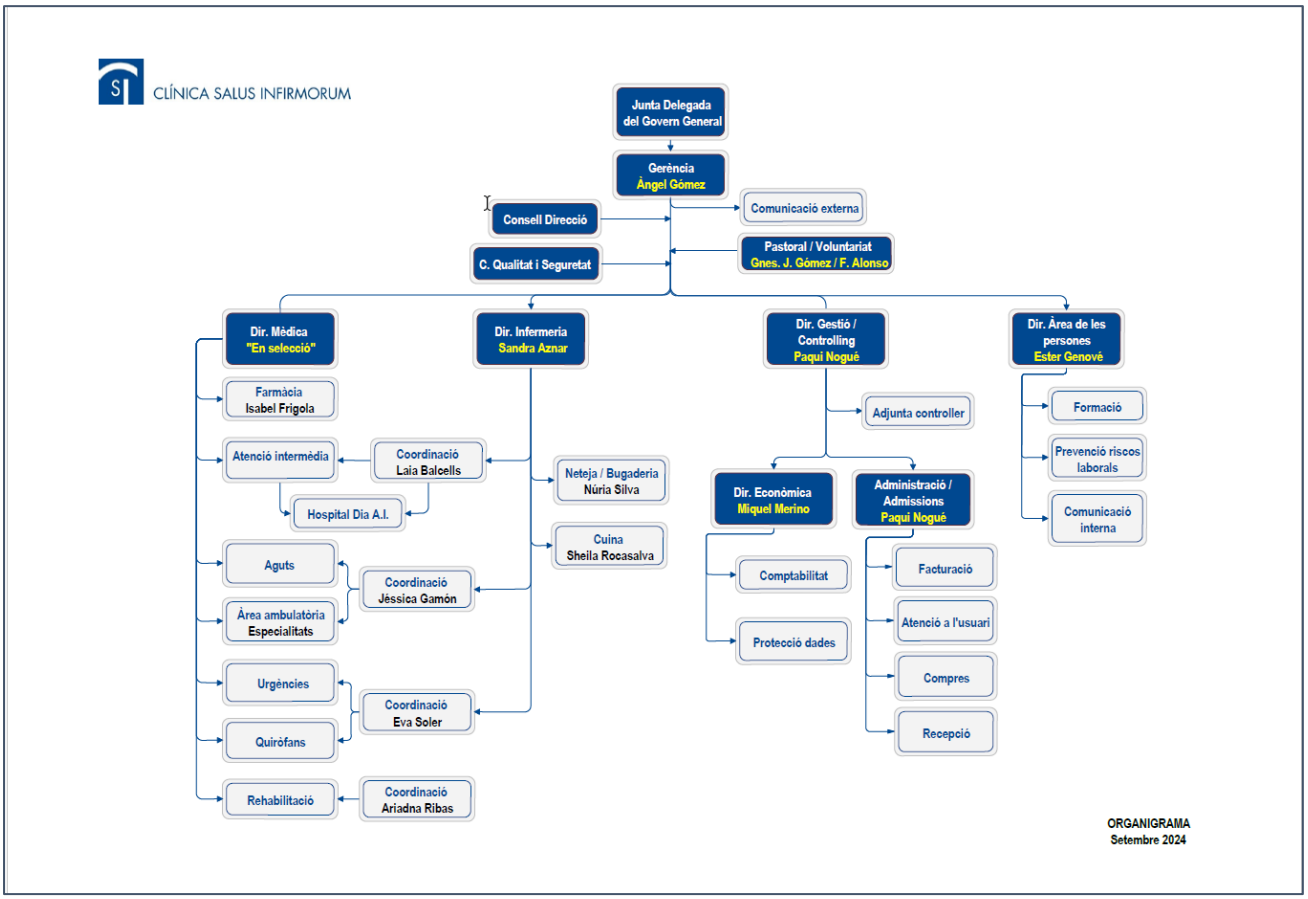
Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

7.3 *Dotació estructural*

24 llits d'hospitalització d'aguts
9 llits UCSI
65 llits d'hospitalització sociosanitària
25 places d'hospital de dia sociosanitari
3 quiròfans majors
5 boxs de recuperació post quirúrgica
16 boxs de consultes externes
3 boxs d'atenció a Urgències amb una sala de triatge
2 llits d'observació d'urgències
1 sala convencional de diagnòstic per la imatge
1 Ressonància Magnètica
1 Farmàcia
1 Gimnàs de Rehabilitació

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

8 Organigrama i equip directiu



9 Atenció especialitzada d'aguts

9.1 *Contractació pública*

La CSI es classifica com a nivell 1 en funció de la seva estructura, sobre els 7 existents, que es denomina "hospital complementari". A Catalunya, acompanyen a la CSI en el nivell 1 quatre hospitals: Clínica NovAliança, Centre MQ de Reus, Clínica Terres de l'Ebre i Clínica Girona.

En els dos darrers anys s'ha produït un augment de l'activitat quirúrgica fruït de les elevades llistes d'espera dels centres públics de Girona que se'ns derivem.

El nombre d'altes mèdiques i quirúrgiques contractat és baix, amb una disparitat important amb l'activitat realment feta, que redunda en una alta marginalitat.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Activitat	2018	2019	2021	Contracte 2022	2022	2023
Altes mèdiques CatSalut	15	12	25	25	26	25
Altes quirúrgiques CatSalut	1.240	1.242	1.315	1.315	2.122	2.110

- **Millora de l'IRR (intensitat relativa de recursos) mèdic i quirúrgic, amb IRE (índex relatiu d'estructura) mancat d'actualització**

L'IRR que mesura la complexitat de les altes, ha pujat notablement a l'any 2023.

En referència a l'IRE en els darrers tres anys la CSI i el IRSJG han fet un gran esforç de reforma, adequació, ampliació i millora de moltes àrees de la Clínica, tant ambulatòries com de proves diagnòstiques i d'hospitalització, que ha comportat l'ampliació i actualització d'equipaments, exemples del qual han estat la ressonància magnètica, l'equip de radiologia convencional, els nous Ecògrafs, els aparells d'endoscòpia, la incorporació del laboratori, etc. L'actual dada de l'IRE està allunyada de la realitat, fet que penalitza al centre.

- **Baixa contractació de Tècniques, Tractaments i Procediments (TTiP)**

L'import i activitat resultant de les TTiP contractades també és inferior a les d'hospitals del mateix nivell estructural, sent els únics conceptes contractats els de la *rehabilitació física ambulatòria* i la *logopèdia ambulatòria.*

La rehabilitació és l'única activitat que ve directament derivada des de l'Atenció Primària. La CSI en els darrers anys ha incrementat notablement l'activitat per sobre el contracte amb el CatSalut per disminuir els temps d'espera, però encara sense suficient reflex en el contracte.

	Contracte 19-20	2019	2020	Contracte 21-22	2021	2022	2023
Fisioteràpia	570	601	621	631	677	811	721
Logopèdia	73	91	85	81	96	85	81

- **Aliances estratègiques: Acords Marc amb l'ICS i l'IDI**

L'any 2021 es van signar acords amb l'ICS i l'IDI, per fer l'activitat de radiologia convencional i de ressonàncies generades per l'ABS de Banyoles.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Activitat	2022	2023
Radiologia Convencional	2.123	
Ressonàncies Magnètiques	801	

- **Urgències: activitat a l'alça i model de finançament per revisar**

L'activitat d'urgències es finança per programa i no per activitat, igual que les Consultes Externes, fet que comporta una assignació econòmica per sota l'activitat pagada segons l'IRU (índex relatiu d'urgències). El model presenta disfuncions quant al seu funcionament, que es descriuran més endavant en aquest document.

Aquestes dades il·lustren una realitat que ha de guiar la tasca de futur immediat del CSI i de l'IRSJG: la contractació pública és encara baixa en relació al seu grup de referència, així com al global d'hospitals del SISCAT. La capacitat de creixement de l'activitat assistencial de la CSI és encara elevada, i per tant **el marge de millora de la contribució que la CSI té per oferir al sistema és alta**.

Els dos fets es produeixen dins un context d'evolució demogràfica de necessitats assistencials en clara alça a la zona de referència, on l'accessibilitat ha passat a ser una clau molt rellevant quant a la suficiència de la resposta del sistema. Creiem doncs que estem davant d'una oportunitat per tots que convé aprofitar.

La CSI té recursos que li permetrien absorbir una major activitat a la contractada, i així contribuir a millorar l'accessibilitat dels pacients amb proximitat, com Ecografies, Endoscòpies, Ecocardiografies, proves d'esforç, etc. L'IRSJG, a més, com a propietari de la CSI, ha mostrat als darrers anys la seva disposició a acompanyar aquest creixement amb l'esforç inversor necessari per arribar a més població i dotar de més resolució al Centre.

- **Accessibilitat Regió Sanitària de Girona. CANVIAR!!!**

Les dades d'espera que facilita el CatSalut a finals de l'any 2022 denoten un empitjorament de les esperes en el processos quirúrgics garantits:

LE RS Girona - Desembre de 2022
Evolució Procediments garantits

Procediments que superen les garanties
Cataractes, Maluc i Genoll
RS Girona

	Jun/19	Des/19	Jun/20	Des/20	Jun/21	Des/21	Gen/22	Feb/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Oct/22	Nov/22	Des/22
Cataractes	14	91	508	309	147	531	679	562	521	597	618	562	719	858	964	967	990	1.086
Maluc	63	76	198	218	175	187	199	179	166	152	138	127	129	148	153	151	149	124
Genoll	159	180	434	490	345	270	307	302	271	280	266	258	273	314	321	304	304	322

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Augment en les esperes de la resta de procediments quirúrgics.

LE RS Girona - Desembre de 2022
Evolució Procediments de + de 365 dies

Procediments amb temps de referència que superen els 365 dies (Excepte cataractes, malucs i genolls)

RS Girona

	Jun/19	Des/19	Jun/20	Des/20	Jun/21	Des/21	Gen/22	Feb/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Oct/22	Nov/22	Des/22
1 - 2 anys	1.427	1.795	3.047	3.563	2.410	2.226	2.298	2.365	2.366	2.473	2.485	2.423	2.510	2.466	2.427	2.342	2.271	2.243
2 - 3 anys	414	362	479	688	865	1.021	1.058	1.020	931	759	720	661	653	658	604	588	549	566
> 3 anys	128	47	160	200	232	297	313	350	375	387	407	400	428	392	368	353	385	417
Acumulat	1.969	2.204	3.686	4.451	3.507	3.544	3.669	3.735	3.672	3.619	3.612	3.484	3.591	3.516	3.399	3.283	3.205	3.226

Els procediments quirúrgics amb més esperes es detallen en el quadre inferior:

LE RS Girona - Desembre de 2022
Resum dels PQ de + de 365 dies amb més pacients acumulats

Principals PQ amb temps de referència que superen els 365 dies (Excepte cataractes, malucs i genolls)

RS Girona - Des de 2022

PQ / Temps	1 a 2 anys		2 a 3 anys		>3 anys	
1	Vasectomia	220	Vasectomia	128	Vasectomia	71
2	Cirurgia instrumentada del raquis	156	Extracció quirúrgica de dent	49	Operacions de mama	42
3	Circumcisió	130	Cirurgia instrumentada del raquis	42	Cirurgia instrumentada del raquis	41
4	Extracció quirúrgica de dent	124	Altres	40	Altres operacions ORL	41
5	Reparacions articulars	113	Operacions d'orella mitjana i interna	32	Septoplàstia, rinoplàstia i int. pl. Nas	29
6	Prostatectomia	108	Operacions de mama	31	Extracció quirúrgica de dent	20
TOTAL		851		322		244

Augment de les entrades de pacients i activitat realitzada en proves diagnòstiques:

LE RS Girona - Desembre de 2022. PD

CatSalut

Llistes d'espera. Proves diagnòstiques

Total - Desembre 2022 (Dades del dia 31/12/2022 a les 23:59)

Data d'avui: 09/01/2023

Regió: GIRONA Àmbit: Total Sector: Total

AGA: Total Unitat proveïdora: Total

Agrupadors	Pacients			Entrades		Activitat acumulada		Temps d'espera per fer visita		Temps d'espera visita realitzada		Pacients dins
	mes en curs	% var. mes ant	% var. tall des	any en curs	% var. any ant	any en curs	% var. any ant	mes en curs	dif. tall des	mes en curs	dif. tall des	% <= 30
Total	18.784	-1,91%	1,08%	86.354	-4,74%	75.266	-2,63%	151	21	61	0	47,08%
Ecografia abdominal	3.277	1,39%	27,46%	10.321	-11,49%	8.071	-12,74%	184	49	65	13	36,41%
Electromiograma	2.917	-2,86%	1,36%	3.985	-23,17%	2.720	-18,64%	297	55	168	33	20,67%
Ecografia urològica	2.359	2,92%	32,60%	7.937	10,76%	6.298	14,14%	165	43	61	3	40,19%
Ressonància magnética	2.188	-12,90%	-24,05%	16.154	-11,76%	15.604	-8,79%	82	11	58	-6	57,40%
Tomografia computada (TC)	2.046	-8,50%	-4,35%	19.475	1,23%	17.991	4,50%	51	-5	37	5	71,41%
Colonoscòpia	1.886	3,74%	4,78%	7.280	6,60%	5.987	2,15%	154	-28	73	-29	46,82%
Endoscòpia esofagogàstrica	1.413	0,28%	-21,06%	6.459	4,48%	5.795	13,54%	125	-37	82	-16	53,64%
Ecocardiografia	1.322	-3,43%	1,54%	6.440	-2,34%	5.664	0,35%	87	22	73	9	59,91%
Polisomnografia	505	6,09%	84,31%	1.105	53,47%	688	25,55%	145	-27	102	33	39,41%
Mamografia	312	3,65%	-18,54%	3.111	-8,37%	2.760	-6,54%	31	-15	26	5	98,08%
Ecografia ginecològica	261	38,10%	-39,58%	1.939	-28,58%	1.728	-26,90%	39	-40	55	-14	85,82%
Ergometria	211	-5,80%	-6,64%	1.174	-6,45%	1.034	-4,44%	72	-6	77	21	66,82%

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

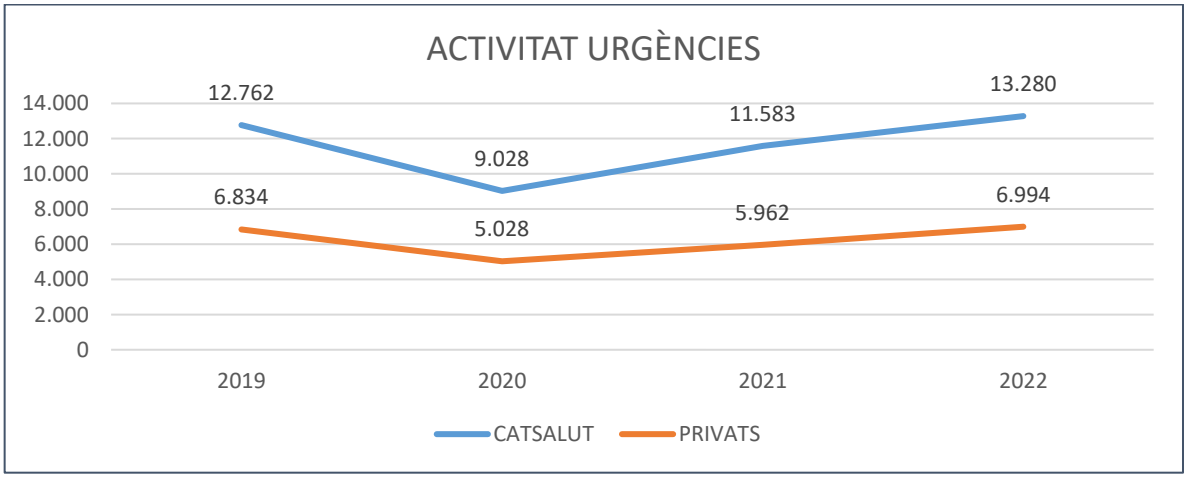
Les esperes per ser visitat per les diferents especialitats han sofert un augment.

9.2 *Activitat d'urgències*

La CSI té servei d'Urgències 24 hores tot l'any, assumint l'atenció continuada pública de la comarca de les 20h fins a les 8h els dies laborables, i les 24 hores els caps de setmana i festius (PAC Banyoles). Els dies feiners, durant el dia, les urgències públiques s'han d'adreçar al CAP Banyoles, a un quilòmetre de la Clínica, que no disposa de laboratori ni radiologia. Les nostres enquestes als usuaris confirmen que aquesta realitat genera molta confusió en el pacient, i manifesten la seva incomprensió davant del fet de no poder accedir a la CSI per urgències públiques sempre, sense distinció d'hores, provocant una disfunció que deriva en una acumulació d'activitat en el servei d'urgències a partir de les 20hores.

El servei està dotat d'un aparell de radiologia convencional i un ecògraf que cobreix les 24 hores pels pacients privats, i sols en horari PAC pels malalts públics. El Laboratori cobreix les necessitats d'urgències amb un perfil analític bàsic d'hemograma, bioquímica, i proves de coagulació, que permet assumir complexitat i donant suport a les unitats d'hospitalització.

Que la CSI disposi de tots els serveis necessaris (laboratori bàsic i radiologia convencional) per atendre la urgència de baixa i mitja complexitat afavoreix la resolució de la majoria dels processos, evita el desplaçament del pacient i la sobrecàrrega de casos de baixa complexitat a l'hospital de referència.



El nombre d'urgències particulars i d'asseguradores és el 34 % del total anual.

El CatSalut contracta les urgències a través del programa "Absorció d'urgències – urgències extra hospitalàries". El nombre d'urgències ateses s'ha anat incrementant en els últims anys, arribant a l'any 2022 una mitjana de 50 urgències/dia.

La realitat del punt d'atenció continuada (PAC) dificulta ja avui dia poder oferir una resposta assistencial adequada a aquesta evolució de la demanda, que continuarà creixent. Creiem que una bona solució podria ser un CUAP, o un servei d'urgències hospitalari, amb una nova clàusula que contractés un número definit de triatges i de visites d'urgència modulades per l'índex Relatiu de Recursos d'urgències (IRU).

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

9.3 *Relacions amb tercers, àmbit públic*

L'atracció de **l'Hospital Dr.Trueta** sobre l'ABS de Banyoles és molt important.

Gran part de l'activitat que es genera a la comarca és de baixa i mitjana complexitat, la qual es pot realitzar a la CSI. Les millores en capacitat resolutiva que ha anat adquirint la CSI han permès que actualment hi hagi un marge de derivació potencial directa des de l'ABS cap a la Clínica que seria molt eficient pel sistema aprofitar, millorant l'accessibilitat de la població.

A l'any 2022 l'IRSJG va signar un Conveni Marc d'aliança estratègica amb l'ICS Hospital Trueta, que possibilita reforçar i ampliar una col·laboració estable entre organitzacions que comparteixen objectius comuns, i treballar accions que impliquin haver d'intercanviar i compartir recursos i capacitats.

9.4 *Atenció Primària de Banyoles*

Una fita aconseguida a l'any 2021 ha estat l'acord amb l'ICS per fer la radiologia convencional de l'ABS, i un acord d'aliança estratègica amb l'IDI per fer les ressonàncies magnètiques de la comarca d'origen ABS. També s'ha signat un conveni amb l'IAS per

l'atenció de la xarxa mental infanto-juvenil. A l'any 2022 es va acordar que els MIR's de Medicina Familiar i Comunitària de l'ABS fessin guàrdies al nostre PAC.

Enfortir la relació entre ambdues entitats és clau per tal de garantir una coordinació entre dispositius que repercuteixi en una millora de l'atenció sanitària.

Creiem que fora convenient pactar una derivació directa des de l'ABS de Banyoles per optimitzar el flux de pacients amb patologies de baixa i mitjana complexitat, sigui de pacients sociosanitaris o aguts.

9.5 *Atenció privada*

L'activitat assistencial privada, d'asseguradores i particulars, està concentrada actualment en l'especialitat de Traumatologia amb una part molt substancial del nombre d'intervencions privades (més del 60 %), tot i tenir menys pes amb la incorporació de noves especialitats.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Quadre d'activitat quirúrgica privada per especialitats:

Activitat	2019	2020	2021	2022
COT	289	236	261	317
Cirurgia gral.	61	46	50	62
Altres	37	29	57	84
Teràpia del Dolor	69	38	76	64
Total	**456**	**349**	**444**	**527**

Quadre d'activitat ambulatòria privada:

La demanda de Traumatologia en Urgències supera la resposta que ofereix la CSI, perdent-se pacients de consultes i per intervencions quirúrgiques.

L'activitat ambulatòria, les urgències i les altes mèdiques han superat els nivells de l'any 2019, el que indica que la demanda després de la pandèmia s'ha recuperat.

Activitat	2019	2020	2021	2022
Consultes	2.071*	2.699*	6.409*	8.398*
Urgències	6.826	5.016	5.949	6.640
Altes mèdiques	21	22	21	22
Rehabilitació	5.724	4.637	6.606	7.590
Cirurgia menor ambulatòria	115	42	96	84
Endoscòpies	-	51	57	132
Ecografies	-	876	1.437	1.760
Radiologia convencional	-	4.216	4.963	6.250
Ressonàncies magnètiques	-	103	1.526	1.740

**No inclou les visites de facultatius no vinculats*

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

10 Atenció intermèdia

L'atenció sociosanitària és principalment de pacients públics, sent anecdòtica encara l'atenció privada, una necessitat amb demanda real que cal satisfer.

La CSI és l'únic dispositiu sociosanitari de la comarca del Pla de l'Estany, i constitueix una resposta assistencial real a una necessitat creixent molt rellevant a la comarca.

Altres dispositius sociosanitaris relativament propers són:

Comarca	Dispositiu	Distància
Gironès	Centre Geriàtric Maria Gay (**IRSJG**)	30 minuts a/cotxe
Gironès	Centre sociosanitari MUTUAM Girona	20 minuts a/cotxe
Gironès	PADES Gironès-Girona-Pla de l'Estany	25 minuts a/cotxe
Gironès	Residència Puig d'en Roca	23minuts a/cotxe

10.1 *Activitat Intermèdia pública de la CSI*

Activitat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Llarga estada	14.170	10.124	13.185	12.035	11.983	12.110
Estades M.E.P.	5.035	5.074	5.548	6.670	6.643	7.150
Estades Hospital Dia	6.044	3.593	4.576	4.850	4.864	5.313

El nombre d'estades han estat inferiors als anys 2020 i 2021 per l'efecte de la Pandèmia, però augmentant i redefinint la tipologia de pacients al guanyar en complexitat i reduint el component social, com indica el Pla estratègic del departament de Salut.

10.2 *Planificació de l'atenció intermèdia*

El Pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya 2023 aconsella els següents ratis de recursos d'internament:

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

Unitat	Ratis o criteri poblacional	
	Mapa sanitari 2008	Planificació 2022
Mitjana estada	Subaguts. Línia assistencial que no existia al mapa sanitari el 2008	1,3-1,4 altes per 1000 habitants
	Convalescència 1,8 llits per 1.000 habitants > 64 anys	2,5-3 llits per 1.000 habitants > 64 anys
	Cures pal·liatives 8-10 llits per 10.000 habitants	
	Unitats polivalents 2,3 llits per 1.000 habitants > 64 anys	3,2 llits per 1.000 habitants > 64 anys
Llarga estada	5 llits per 1.000 habitants > 64 anys	3-2,5 llits per 1.000 habitants > 64 anys
Hospital de dia	1,5 places per 1.000 habitants > 64 anys	
CEI	Almenys 1 Consulta Externa Interdisciplinari per GTS	
PADES	1 equip per a cada 100.000 habitants	
ESH	1 Equip de Suport Hospitalari per a cada hospital d'aguts com a mínim	

Font: Pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya 2023

Considerant <u>només l'ABS de Banyoles</u>, amb una població de 32.854 habitants, 6.263 majors de 64 anys, i aplicant els ratis, els resultats son els següents:

Tipus d'atenció	Rati	Resultat teòric	Real	Superàvit/ Dèficit
Llarga estada	3-2,5 llits /1.000 > 64 anys	21,8 llits	**32**	**Superàvit**
Convalescència	2,5-3 llits /1.000 > 64 anys	17,2 llits	**17**	**Adequat**
Cures pal·liatives	0,8-1,0 llits /10.000 habitants	3 llits	**3**	**Adequat**
Mitjana estada poliv.	3,2 llits/1.000 > 64 anys	20 llits	**21**	**Adequat**
Hospital de Dia	1,5 places/1.000 > 64 anys	9,4 places	**23**	**Superàvit**
Unitats subaguts	1,3-1,4 altes / 1.000 població gral.	45,0 altes	**-**	**No contractat**

<u>Places de llarga estada</u>: Oferta superior a la teòrica si només apliquem població ABS.

<u>Places de mitja estada polivalent</u>: Oferta adequada per l'ABS, però l'AGA és insuficient. Unitats de subaguts: Només s'atenen a l'I.A.S.a Girona.

Els Programes EAIA no es consideren necessaris per una població de referència com la nostra.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

10.3 *Dispositius sanitaris i socials del Pla de l'Estany*

Altres dispositius sanitaris i socials del Pla de l'Estany	
Sanitaris	**Sociosanitaris**
Clínica Salus Infirmorum Montepio Mutualitat de Salut Mutua Intercomarcal	Clínica Salus Infirmorum - Llarga estada - Mitja estada polivalent - Hospital de dia
Serveis d'ajuda a domicili	**Residències**
Artris 2000 Serveis Socials Maria Rovirola Abuli (SAD) Mayary Serveis SAD Geroconsultors Ventall 2008 XartexSan Sumar	Residència La Solana Residència El Mirador de l'Estany Residència La Vila Gran Residència El Vellet Residència La Torre Residència la Bella Tardor Residència Can Carré Residència Pla de Martís Residència Vall del Terri Asil Santa Teresa de Jornet Residència Els Cirerers Residència Can Siques
Centres de Dia	
Centre de Dia Sagrat Cor de Jesús Centre de Dia El mirador de l'Estany Centre de Dia El Vellet Centre de Dia Can Carré Centre de Dia La Torre Centre de Dia Pla de Martís Centre de Dia Vall del Terri Centre de Dia El Fluvià Centre de Dia Bella Tardor	

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

10.4 *Activitat Intermèdia privada*

L'atenció hospitalària privada actualment es mínima, malgrat existir la demanda d'aquest dispositiu.

Activitat	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
Estades M.E.P.	80	143	107	199	70

11 Satisfacció i fidelitat

Els resultats de la Clínica són bons, segons les enquestes de satisfacció (OPINAT)

Satisfacció i fidelitat	Fidelització	96,6%	
	Satisfacció global	9,52	

12 Recursos Humans

La plantilla total mesurada en Personal en Plantilla Equivalent, és de gairebé 180 contractes laborals. El nombre de contractes mercantils és d'uns 60.

L'edat mitjana dels treballadors és de 42 anys, i una antiguitat inferior a 10 anys.

En els darrers anys s'ha produït un increment de plantilla per donar resposta a l'augment d'activitat i complexitat derivada del CatSalut, i les noves especialitats i nous facultatius incorporats.

El conveni laboral d'aplicació és el Conveni Col·lectiu de treball del SISCAT.

Cada any s' elabora un programa de formació adequat a les necessitats professionals i els requeriments assistencials. La finalitat és potenciar la generació del talent i assolir les competències canviants, que recolzin el desenvolupament organitzatiu a nivell laboral, tècnic i humà, i tenint com a referent la missió i els valors de CSI.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

13 Conclusions i línies de treball futures

- La CSI està infrautilitzada per la població del Pla de l'Estany, malgrat tenir els recursos estructurals, equipaments, especialitats i professionals per donar una major atenció, en número i complexitat, per pacients públics i privats.

- En relació a **l'ABS de Banyoles**, actualment només és fan les proves de radiologia convencional, ressonàncies magnètiques, i la rehabilitació, però és podria avançar en altres serveis i proves per millorar l'accessibilitat, avançant en el desplegament de l'atenció a domicili, l'atenció sociosanitària i d'aguts.

- Les esperes en **procediments quirúrgics**, proves diagnòstiques i consultes han augmentat en la Regió de Girona, i en algunes d'elles la CSI pot ajudar a reduir-les.

- En els darrers dos anys s'ha d'incrementar el flux de pacients de baixa i mitjana complexitat a la CSI, sobretot de l'ABS de Banyoles, aprofundint alhora en les relacions amb l'ABS, l'HJT i IDI que les **aliances estratègiques** permeten. El cost econòmic, pel mateix procediment, de la CSI és molt més baix pel CatSalut que en qualsevol de la resta de centres, i milloraria l'accessibilitat reduint els temps d'espera.

- L'**atenció intermèdia** ha de continuar adaptant-se als criteris del Pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya 2023, i reconduir estades de llarga estada, augmentar les de convalescència, i cures pal·liatives, i reduir el nombre d'estades d'Hospital de Dia.

- La conversió del PAC de la Clínica en un **servei d'urgències hospitalari** de 24 hores/365 dies és una de les principals demandes de la comarca i punt crític per resoldre: a la població se li fa molt difícil entendre que ha accedir als diferents serveis segons l'horari dels professionals de l'ABS. Solucionar satisfactòriament aquest problema (sigui amb CUAP, sigui amb servei hospitalari d'urgències), milloraria en gran mesura la satisfacció dels pacients, i per a la CSI seria una palanca de visibilitat com a centre d'urgències.

- El CatSalut té definida la CSI com un hospital complementari, i dins d'aquesta categoria és un centre amb una assignació baixa de recursos contractats. La CSI ha millorat notablement la seva dotació i capacitat de resposta assistencial en els darrers anys, i aspira a assumir més competències i pujar de nivell, amb alta coordinació i col·laboració amb l'HJT, l'IAS i l'ABS de Banyoles.

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

- En l'esfera privada la CSI s'ha de convertir en el punt de referència comarcal, augmentant el nombre d'especialitats i de mitjans diagnòstics, el que redundarà en la reversió del flux dels clients que ara són atesos a Girona. Cal augmentar la resolució de la demanda i resposta en l'especialitat de Traumatologia a Urgències, de pacients que actualment són derivats per ser atesos a Girona.

14 Eixos estratègics

A continuació es defineixen **els objectius estratègics** amb els seus **plans d'acció**, **responsable del projecte**, **indicadors** i **cronograma** (entre parèntesi). Si no s'especifiquen dates, significa que és per cadascun dels 4 anys de durada del Pla

14.1 *Organització eficient i sostenible*

L'IRSJG i la CSI estan centrats en l'atenció a les persones, amb un model sostenible i eficient en base als recursos disponibles. Certes transformacions són necessàries per donar un bon servei als pacients i fidelitzar als professionals.

L'autoavaluació, cercar d'altres sistemes organitzatius, el benchmarking, i la innovació, han de servir de motor pels canvis necessaris per a la millora de l'atenció, l'organització i el funcionament.

14.1.1 Sostenibilitat amb equilibri pressupostari

Responsables: Gerència / Direcció econòmica

a. **Augmentar els ingressos econòmics**
   - Millorar els contractes del CatSalut, Asseguradores, IDI, i ICS.
     a. Objectiu CatSalut:
        i. Especialitzada: Increment progressiu contracte > 25 % a finals 2026
        ii. Intermèdia: Increment progressiu contracte > 10% a finals de 2026
     b. Objectiu IDI:
        i. RMN: Activitat > 1000 pacients/any
     c. Objectiu ICS:
        i. Radiologia convencional: Activitat > 13.000 pacients /any
     d. Privada:
        i. Asseguradores: Increment progressiu facturació > 30 % a finals 2026
        ii. Particulars: Increment progressiu facturació > 12 % a finals 2026
   - Diversificar l'activitat pública i privada. (2024-26).
     a. Pública:
        i. Assumir l'activitat d'ecografies d'AP Banyoles abans 2025
        ii. Assumir l'activitat d'endoscòpies d'AP Banyoles abans 2026
        iii. Assumir intervencions quirúrgiques de LLEQ de l'especialitat de Maxil·lo Facial a l'any 2024
        iv. Assumir de l'especialitat de a l'any 2025
        v.
     b. Privada:

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

i. Convalescència: ▲ nº estades > > 20% 2024, 2025: 30% 2026: 40%
ii. Hospital de Dia: Pacients privats: Any 2024, > 8, Any 2025: >12
iii. Mútues laborals: Increment progressiu d'ingressos ▲ 30 % any 2026
iv. Mútues Esportives:
    1. Obtenir l'Acreditació Med. Esport 2024
    2. Increment activitat Consulta Esport: 2024 > 20 %, 2025: 30 %
v. Particulars: ▲ activitat > 8 %2024, 2025: 12 % 2026: 16 %
vi. Asseguradores mèdiques: ▲ activitat > 10%, 2025: 15% 2026: 20%
vii. Acords amb centres Mèdics:
    1. Centre La Mèdica d'Olot: contracte de col·laboració 2024, per atenció ambulatòria i quiròfans

- Obrir les aliances estratègiques amb tots els centres hospitalaris de la Regió de Girona.(2024-26):
    i. Establir acords amb d'altres centres de Girona:
        1. Corporació Blanes-Calella: Contracte Endoscòpies 2024, prorrogable.
        2. Proposar contracte endoscòpies 2024: H. Figueres, i Hospital d'Olot

b. Control de costos

- Seguiment del compte de Resultats, en particular dels consums-costos:
    i. Establir reunions bimensuals amb totes les direccions 2024
    ii. Monitoritzar comptes claus de cada àrea 2024-25
- Racionalitzar l'eficiència de la despesa: compres, consums i contractacions externes
    i. Establir sistemàtica de 3 propostes per les noves contractacions 2024
    ii. Elaborar criteris d'anàlisi detallat de les principals compres/consums 2024-2025
    iii. ...

c. Cercar noves vies de finançament privat

- Noves especialitats, proves o serveis:
    i. Potenciar Rehabilitació:
        i. Indiba > 20 % 2024, 30 % 2025, i 35 % 2026
        ii. Incontinència urinària > 20 % 2024, 30 % 2025, i 35 % 2026
        iii. Punció seca
        iv. Teràpia neural > 20 % 2024, 30 % 2025, i 35 % 2026
    ii. Med.Esport:
    iii. Nutrició:
    iv. Peu diabètic
    v.
- Noves asseguradores, entitats o acords:
    i. Contracte amb el mercat assegurador mèdic > 95 %
    ii. Contracte amb el mercat assegurador laboral > 90 %

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

- Noves línies de negoci:
  i. Incorporar l'especialitat Neurologia 2024
  ii. Incorporar l'especialitat d'endocrinologia 2024-25
  iii.

d. Millorar la viabilitat financera

- Mantenir saldos ajustats d'estocs, tot garantint-ne els aprovisionaments necessaris per acompanyar l'activitat.
- Control acurat de la tresoreria.
- Prudència financera de l'IRSJG, amb política d'endeutament zero.
- Control ajustat dels pressupostos i execució d'inversions.
- Esforç addicional en la cerca d'ajuts a la inversió.

14.1.2 Millorar la gestió administrativa – econòmica

Responsables: Direcció d'admissions i facturació/ Direcció econòmica

a. Enfortir els criteris i conceptes de facturació

- Dades de facturació de totes les àrees.(2024-26)
- Reunions administratives – assistencials de coordinació.

b. Major interoperabilitat amb les plataformes del sector i partners tecnològics

- Adaptació als canvis de les plataformes de les asseguradores.
- Minimitzar les incidències en facturació.

c. Rigor en la codificació i en les dades bàsiques assistencials i administratives

- Millora del número, qualificació de codis, incidències de CMBD i CMBD-UR

d. Revisió i re-disseny dels circuits i funcionament administratius- assistencials

- Digitalització de l'arxiu, eliminació i d'escaneig HC.
- Anàlisi d'activitat (ocupació, ratis,...), despeses i assignació de recursos, amb rendibilitat resultant, per àrees.(2024-26)
- Comptabilitat analítica d'activitat vs assignació de recursos, dels principals processos (2024-26)

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.1.3 Noves tecnologies per millorar l'eficiència

Responsables: Direcció d'admissions i facturació/ Direcció econòmica

a. **Evolucionar cap a unes eines i equipaments accessibles, robustos per la presa de decisions.**
   - Inventari actualitzat dels equipaments i les estructures.
   - Pla anual d'actualització d'equipaments- amortitzat.

b. **Consolidació i incorporació de programes de Sistemes i TIC per millorar els processos, la traçabilitat i l'automatisme.**
   - Implantació i desenvolupament.

c. **Millorar la cerca documental i unificar documents amb visió transversal.**
   - Ús de tecnologies i reducció tasques administratives i paper.
   - Processos interconnectats i transversals.(2024-26)

14.1.4 Eficiència energètica i ecològica dels edificis/espais

Responsable: Gerència

a. Disseny d'una Política i Pla ambiental
   - Conscienciació i implicació dels professionals. (2024-26)
   - Accions d'impacte mediambiental. I gestió de residus
     i. Mesures introduïdes i resultats
     ii. Estadístiques d'estalvi materials. (2024-26)
     iii. Canvis en els usos de substàncies i materials.
   - Nº incidències de seguretat i infraestructura. (2024-26)
   - Accions d'estalvi energètic:
     i. Accions de climatització: consums energètics amb ratis
     ii. Consums telefònics

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.2 *Model Assistencial excel·lent i accessible a la població*

L'envelliment de la població, les noves formes d'atenció de salut de les persones, valors i expectatives de la ciutadania, més els avenços diagnòstics, terapèutics i tecnològics ens han de fer reflexionar sobre el tipus d'atenció que oferim per anar adaptant els canvis precisos per l'atenció.

El Pla de Salut de Catalunya orienta els objectius per donar resposta a aquests reptes de manera global, a través d'accions de promoció i protecció de la salut, prevenció de les malalties, tractament de les persones malaltes, rehabilitació i reinserció a la societat en les millors condicions possibles. La CSI vol continuar adequant i enfortint el seu model d'atenció per millorar els resultats en el pacient, amb la participació i gestió que aquest fa de la seva malaltia, de manera sostenible i eficient, plantejant accions que ens ajudin a avançar.

14.2.1 Millorar les estructures, equipaments i instal·lacions

Responsable: Gerència

a. **Estudi, modernització i adequació de l'edifici, instal·lacions, i equipaments**.
   - Elaboració Pla Director i Funcional. (2024-26)
   - Pla d'Inversions: estructural i d'equipament.
   - Actualització del Pla de seguretat (2024-26)

b. **Cultura d'atenció per garantir l'òptima experiència del pacient, amb accessibilitat, confort i satisfacció.**
   - Resultats de les enquestes d'avaluació i satisfacció.
   - Temps d'espera
   - Accions de millora:
     i. Paràmetres d'estadística telefònica, informatives, de garantia d'intimitat. (2024-26)
     ii. Espais d'hostaleria i de serveis generals: cuina, neteja, manteniment.... (2024-26)
     iii. Àrees d'atenció sanitària.
     iv. Altres demandes: aparcament, i entorn amigable. (2025-26)
     v. Nous paquets de serveis "ad hoc" per atraure nous pacients. (2024-26)
     vi. Servei d'atenció Pastoral de la Salut (SAER)

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.2.2 Desenvolupament de la Clínica i augment de resolució

Responsable: Direcció mèdica/ Direcció d'infermeria

a. **Assumpció de major complexitat d'hospitalització, cercant una classificació i rol superior**
   - Evolució del case - mix.
   - Evolució de la tipificació del nivell (2025-26)
   - Reducció de derivacions intracentre i trasllats (2024-26)
   - Intervencions urgents /especialitat. (2025-26)

b. **Augment i ampliació de proves complementàries.**
   - Catàleg de proves (2025-26)

c. **Augmentar resolució des d'Urgències a Consultes, proves, Fisioteràpia...**
   - Registre d'origen derivació
   - Interconsultes entre professionals de la CSI.

d. **Desenvolupar plans funcionals i estandarditzar l'atenció multidisciplinar dels processos més habituals AI, AE i Urgències**
   - Protocols /procediments. (2024-26)

e. **Coordinació amb els recursos socials, sociosanitaris i sanitaris:**
   - Col·laboracions amb altres proveïdors en programes de salut comunitària i preventiva (2024-26)
   - Seguiment de la conciliació dels tractaments entre l'AI i l'AP.
   - Pacients amb pre-alta a domicili.
   - Registre de destí de l'alta: domicili, derivació, residència... (2024-26)

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.2.3 Reorientar l'Atenció intermèdia seguint criteris del Pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya 2023

Responsable: Direcció mèdica

a. Ratis de dispositius LLE, MEP, Cures Pal·liatives, H. Dia...

14.2.4 Avançar en qualitat i seguretat del pacient

Responsable: Direcció mèdica/ Direcció d'infermeria/ coordinació de Qualitat

Per assolir-ho s'aplicaran les normes i disposicions del document **SALU-CA-GEC-E-01-07.- Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient**

a. Resultats dels objectius del CatSalut d'AE i AI
b. Quadre de comandament de gestió de la qualitat i seguretat
c. Resultat de l'acreditació d'Aguts del CatSalut, AI i Urgències.
d. Millora dels paràmetres de l'auditoria Sociosanitària i Urgències.

14.3 *Desenvolupament professional i gestió de les persones*

Els nostres professionals fan realitat l'atenció sanitària, amb qualitat, respecte i bon tracte. Per seguir progressant és imprescindible cuidar als professionals, dotar-los de les eines necessàries, potenciar la seva formació continuada, promoure la seva participació activa i comunicació, i reconèixer la tasca que desenvolupen . Els objectius i accions pretenen reforçar les capacitats i les competències.

14.3.1 Reconeixement i promoció professional

Responsable: Direcció de l'Àrea de les persones

a. Identificar els professionals referents per transformar el model assistencial, amb qualitat i eficiència

- Avaluacions de competències, feed back amb responsable i resultat DPO's.
- Detecció de capacitat de lideratge, per promoció o canvis interns. (2024-26)
- Catàleg de llocs de treball per la mobilitat interna. (2024-26)
- Accions de reconeixement dels professionals, externs i interns. (2024-26)
- Model per incentivar el desenvolupament i la participació en activitats formatives. (2024-26)

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

b. Participació (comissions clíniques, actes socials,...)

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

14.3.2 Potenciar les habilitats i l'expertesa professional

Responsable: Direcció de l'Àrea de les persones

a. **Registre curricular actualitzat**
b. **Registre d'accions formatives i grau d'implementació**
c. **Cartera d'activitats formatives.**
d. **Disseny d'itineraris formatius –alineats amb el Pla estratègic– (2024-26)**
e. **Millorar els processos interns d'avaluació, seguiment-acompanyament de la Formació continuada.**
f. **Formacions en habilitats comunicatives amb el pacient.**

14.3.3 Potenciar el lideratge dels comandaments

Responsable: Direcció de l'Àrea de les persones

a. **Descripció del lloc de treball per competències**
b. **Protocol de selecció segons descripció del lloc de treball**
c. **Seguiment anyal de les responsabilitats amb avaluació i accions**

14.3.4 Atracció i fidelització de professionals

Responsables: Direcció de l'Àrea de les persones/ Direcció mèdica/ Direcció d'infermeria

a. **Potenciar especialitats i serveis referents**:
   - Accions de consolidació d'especialitats.
   - Accions de reforç de l'especialitat de Medicina de Família.

b. **Registre d'accions per promoure el sentiment de pertinença i orgull**
   - Reconeixements, beneficis socials
   - Aportacions dels professionals implantades. (2024-26)
   - Projectes específics ad hoc. (2024-26)
   - Relació i participació dels professionals externs.
   - Accions informatives i participatives.
   - Enquesta de Clima laboral.

c. **Registre d'accions d'assumpció del Codi Ètic (2024-26)**

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

d. **Registre de les millores dels espais de treball. (2024-26)**

14.3.5 Millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral

Responsable: Direcció de l'Àrea de les persones

a. **Accidents % i tipus**
b. **Formació especifica anyal**
c. **Seguiment de les baixes % i tipus**

14.4 *Comunicació, participació i accessibilitat*

El sector està immers en una situació complexa i canviant, per això és important que la comunicació acompanyi i ajudi a entendre-la i adaptar-s'hi. Hem de ser proactius, transparents i vetllar perquè la informació flueixi entre els professionals, pacients, acompanyants, institucions i l'entorn, afavorint el diàleg i compartint l'anàlisi dels problemes amb els grups d'interès per millorar l'organització.

14.4.1 Millora de la Comunicació interna i externa

Responsable: Gerència/ Direcció de l'Àrea de les persones

a. **Potenciar la comunicació amb els professionals**
   - Correus informatius a intranet: novetats, comunicacions...
   - Activitats amb els professionals global CSI

b. **Augmentar la visibilitat, reconeixement i la imatge institucional**
   - Activitats divulgatives per tipus (memòria, fulletons...)
   - Col·laboracions amb la Comunitat: xerrades, TV, revistes...
   - Registre d'activitats a xarxes socials: número, seguidors i tipus
   - Creació d'un llistat d'empreses, societats... amics de la CSI.
   - Esponsorització d'activitats culturals/esportives de la zona.
   - Manteniment actualitzat de la web, monitors del centre....

c. **Incorporar a la web corporativa l'espai específic per a la participació**:
   - Nº de contactes
   - Seguiment i millora de la web

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'Institut de Religioses de San Josep de Girona.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.

d. Actualització del Pla de Senyalització externa i Interna

- Actualització de la Senyalització, interiorisme, i d'implantació

14.4.2 Atenció a l'usuari

Responsable: Direcció d'admissions i Facturació

a. Millorar la satisfacció i fidelització dels pacients.

- Enquestes, queixes, reclamacions i mesures.
- Registre de les respostes: temps, responsable, i seguiment
- Registre d'incidències accessibilitat, recepcions, i mesures.
- Compliment de la LOPD.
- Coneixement dels drets i deures.

14.4.3 Avançar en la Responsabilitat Social

Responsable: Gerència

a. Accions implantades de Responsabilitat Social (2024-26)
b. Divulgar l'acció social de l'IRSJG (2024-26)

15 Responsabilitat del Pla Estratègic

El responsable del seguiment i compliment del Pla és la gerència del centre.

16 Vigència, revisió i actualització

La vigència del Pla estratègic és de 4 anys, del 2023 a 2026, fent una actualització i revisió del compliment en base als indicadors i fites assolides.

Per a l'elaboració del Pressupost anyal és té en compte el Pla estratègic amb les seves fites previstes anyals, i la dotació de recursos humans i materials.

El cronograma dels objectius abasta en la majoria d'ells els quatre anys, però en alguns s'indica els anys que es comencen a implantar.

17 Ubicació de les còpies i formats

Aquest document es troba en format electrònic a la intranet i al servidor S:\ Serveis\ Acreditació \Documents \1 Lideratge

Aquest document és d'ús exclusiu del personal de l'**Institut de Religioses de San Josep de Girona**.
Està prohibida la seva reproducció i divulgació sense autorització.